



Como o Visitare prioriza as visitas

Motor PRIO-ACS — determinístico, auditável, sem IA na decisão clínica.

score por paciente · 0-100

1 Os dados disponíveis

Fonte: [base anonimizada da SMS-Rio](#) (Prefeitura do Rio) — ~98 mil pacientes em 49 equipes.

Tabelas: `pacientes` · `visitas` · `eventos_clinicos` · `equipes`.

Destas, o motor lê **apenas as colunas necessárias** para pontuar:

pacientes hipertenso · diabetico · gestacao · situacao_vulnerabilidade · faixa_etaria · endereco_lat/long

eventos_clinicos tipo (≠ agendamento) · data_referencia → eventos não-eletivos em 90 d

visitas registrados_em → tempo desde a última visita (gap)

equipes endereco_latitude · endereco_longitude → distância ao posto

2 Como o cálculo funciona

$$\text{PRIO-ACS} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \in [0, 100]$$

C₁ · Risco de internação evitável

0-35

Conta **quantas** condições crônicas (hipertensão, diabetes, gestação) o paciente tem. Os valores são acumulados: a 1ª condição soma **+15**, a 2ª **+12**, a 3ª **+8**.

Total: 1→15 · 2→27 · 3→35.

C₂ · Fase da vida vulnerável

0-25

Selecionamos o **maior valor** entre gestante (25), criança 0-6 anos (20) e idoso 66+ com crônica (15) — usa só o maior, nunca soma.

C₃ · Lacuna de cuidado / urgência

0-25

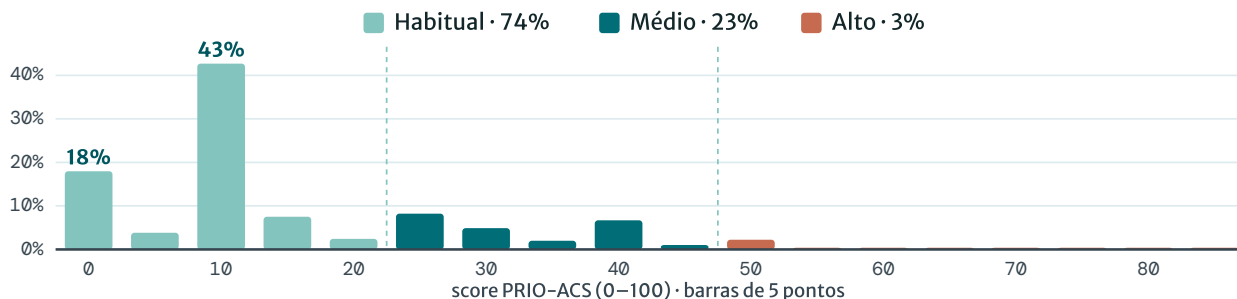
Quem precisa de visita agora. Soma duas parcelas: **emergência recente** (UPA/internação em 90 d) vale **até 15**; **atraso na visita**, além do prazo esperado do caso, vale **até 10**. Quanto mais recente ou mais atrasado, mais perto do máximo.

C₄ · Vulnerabilidade social

0-15

Marcador sim/não na base: paciente sinalizado como vulnerável soma **15**; senão, **0**. Entra como **critério de desempate** entre perfis clínicos parecidos.

Distribuição do score na base atual · 97.938 pacientes (corte dez/2025)



Cauda curta de prioridade: ~3% Alto e ~23% Médio concentram o esforço, ~74% Habitual. Os cortes de faixa são derivados por equipe a cada rodada.

3 Decisões de modelagem

- **Pesos calibrados por fonte oficial.** Portaria SAS/MS 221/2008 (grupos ICSAP), manuais do ACS-MS e fichas da SMS-Rio.
- **Determinístico, sem LLM em runtime.** Mesma entrada → mesma saída; regra inspecionável em SQL/Python. Requisito de auditabilidade clínica.